

2026-27 절기 인플루엔자·코로나19 입원 전망: 정책 브리핑

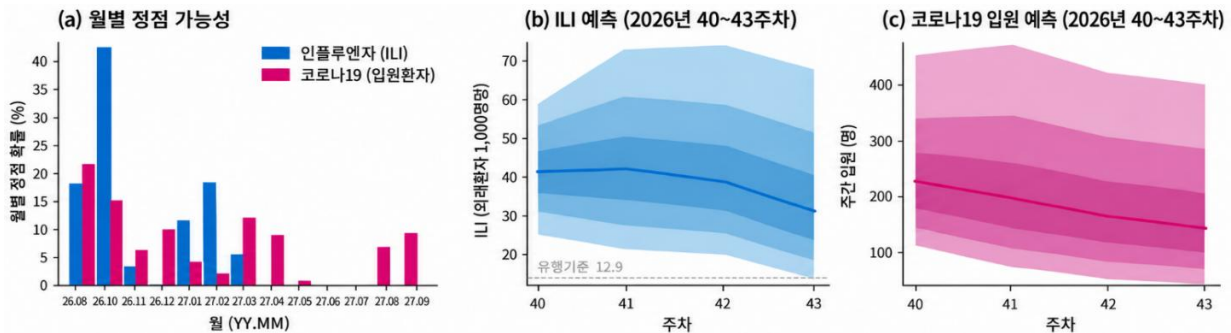
분석 개요 질병관리청 표본감시 자료의 인플루엔자 의사환자분율(ILI)과 코로나19 입원환자 수를 활용하여 2026년 40주부터 2027년 35주(2026-27절기)까지 49주의 유행 양상을 전망하였다.

핵심 전망

- 인플루엔자와 코로나 19의 입원 정점 시기를 살펴본 결과, 인플루엔자는 2026년 40-44주(9.27-10.31)의 정점 확률이 42.2%로 산출되었으며, 코로나 19는 36-40주(8.30-10.3)의 정점 확률이 21.1%로 산출되었다.
- 인플루엔자와 코로나 19의 개별 입원 정점 시점을 비교한 결과, 두 정점이 같은 달에 나타날 확률은 12%이며, 정점 간 시차가 2주 이내일 확률은 21%이다. 두 감염병의 주별 입원환자 수를 합산한 경우, 2026년 40-44주(9.27-10.31)의 정점 확률은 40%로 산출되었으며, 해당 정점 규모의 중앙값은 1,193명(95% 예측구간 548-2,679명)으로 전망되었다.
- 2027년 여름철 인플루엔자 재유행 가능성을 평가한 결과, 27-35주(7.4-9.4)에 인플루엔자 발생이 유행기준을 초과할 확률이 21%로 산출되었다[유행기준: 2025-26절기 기준, 외래환자 1,000명당 ILI 9.1명 이상].
- 단기 예측에서는 인플루엔자 유행은 10월 중순까지 증가한 뒤 정점에 가까워질 것으로 예측된다.

전망 해석 인플루엔자 입원 정점은 9-10월에 나타날 확률이 약 61%로 산출되었으며, 2027년 1-3월에도 약 34%의 정점 가능성이 남아 있어 가을뿐 아니라 겨울철 유행 가능성도 함께 고려할 필요가 있다. 반면 코로나19는 2026년 9-10월의 정점 확률이 36%로 상대적으로 높게 산출되었으나, 12월 10%, 2027년 3월 12%, 8-9월 17% 등 다른 시기에도 정점 가능성이 분포하고 있어 특정 시기로 한정하기 어렵다. 이에 따라 고령층 예방접종(10.6-10.15) 시기의 실제 관측값을 초기 판별 기준과 비교하여 대표 전망의 유지 여부를 판단하고, 기준 범위를 벗어나는 경우 최신 관측자료를 반영해 전망을 갱신한다.

<그림> (a) 입원환자 정점 월별 확률분포, (b) ILI 및 (c) 코로나19 입원의 2026년 40-43주 예측구간(50%, 80%, 95%)과 중앙값.



세부 전망 및 대응 기준

예측 항목	주요 결과 및 대응
동시 정점 및 입원 부담 (Q-a)	• 인플루엔자 입원 정점: 2026년 40-44주(9월 27일-10월 31일) 정점 확률 42.2%. • 코로나 19 입원 정점: 2026년 36-40주(8월 30일-10월 3일) 정점 확률 21.1%. • 두 감염병의 입원 정점이 같은 달에 나타날 확률 12%, 정점 간 시차가 2주 이내일 확률 21%. • 두 감염병의 주별 입원환자 수를 합산한 경우, 40-44주 정점 확률 40% 및 해당 규모 중앙값 1,193명(95% 예측구간 548-2,679명). 정점이 동시에 나타날 가능성은 12%이나, 인플루엔자 정점기에도 코로나19 입원이 지속될 수 있어 두 감염병의 입원환자 수를 함께 고려할 필요가 있음. - 40-44주를 중심으로 두 감염병의 입원 수요가 함께 증가할 가능성이 있어, 해당 시기의 병상·진료 대응 여력을 검토할 필요가 있음. - 고령층 예방접종 개시 시기(10.6-10.15)가 인플루엔자 입원 정점 가능 시기와 일부 겹치는 만큼, 접종 개시가 지연될 경우 충분한 면역이 형성되기 전 입원 수요가 증가하는 기간이 발생할 수 있음.
초기 전망 판별 (Q-b)	• 4주 합계 기준: ILI 105-206(80%), 84-251(95%); 코로나 19 입원 421-1,168명(80%), 295-1,571명(95%). - 40-43주(9.27-10.24) 관측값이 모두 80% 예측구간 내에 있거나, 4주 합계가 80% 예측구간 내에 있는 경우에는 대표 전망을 유지하는 것으로 판단 - 예측 4주 중 2주 이상 또는 4주 합계가 95% 예측구간을 벗어나는 경우에는 대표 전망을 재검토하고, 최신 관측자료를 반영하여 시나리오 설정을 조정한 뒤 향후 4주 전망을 다시 산출.
2027년 여름 상승 가능성 (Q-c)	• 2027년 27-35주(7.4-9.4) ILI가 2025-26절기 유행기준을 다시 초과할 확률 21%. • 산출 근거: 모형 기반 조건부 확률 17% 및 과거 8개 시즌 중 2개 시즌에서 유행기준을 다시 초과한 사례(25%) 반영. - 2027년 여름철 재유행 확률은 21%로 산출되어, 물량·병상 계획 수립 시 위험 시나리오로 함께 고려할 수 있음. - 27주 이전부터 ILI와 A(H1N1)pdm09 등 아형별 검출률의 변화를 확인하고, 유행기준 재초과 또는 아형 검출률의 뚜렷한 상승이 관찰되는 경우 이후 입원 전망을 상향 조정하는 방안을 검토할 수 있음.

가장 불안한 가정 하나 우세 아형·변이의 전환 시점 및 증가 양상에 대한 설정. 인플루엔자의 경우 A(H3N2) 상승 시점을 48주 이후로 두고 A(H1N1)의 감소 양상을 과거 유행 패턴에 기반해 설정했으며, 코로나19는 과거 변이 교체 사례를 바탕으로 신규 변이의 50% 점유 시점과 이후 증가 양상을 설정하였다. 실제 전환 시점이나 변화 양상이 다르게 나타날 경우 정점 시기와 입원 규모에서 차이가 발생할 수 있다.